

ΚΡΙΣΗ ΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Γενικά: «Ουρική αρθρίτιδα» ονομάζεται το φλεγμονώδες νόσημα που προκαλείται από την εναπόθεση κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου στις αρθρώσεις, αλλά και εξωαρθρικά.

Αποτελεί μέρος του φάσματος της **χρόνιας ουρικής νόσου**, που περιλαμβάνει:

1. την ασυμπτωματική υπερουριχαιμία,
2. την οξεία ουρική αρθρίτιδα (κρίση),
3. τη χρόνια τοφώδη ουρική αρθρίτιδα,
4. τη νεφρολιθίαση.

Κοινός παρονομαστής, των τεσσάρων παραπάνω εκδηλώσεων, είναι η υπερουριχαιμία. Η νόσος συσχετίζεται με παθήσεις ή καταστάσεις, όπως: ΑΥ (λήψη διουρητικών), ΧΝΝ, ΣΔ, παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο, καρδιαγγειακές νόσοι (λήψη σαλικυλικών), χρόνια αιμόλυση, ψωρίαση, νεοπλασμάτα, μυελοϋπερπλαστικές νόσοι, αλκοολισμός, κ.ά.

Η υπερουριχαιμία είναι αποτέλεσμα είτε της αυξημένης παραγωγής, είτε της μειωμένης απέκκρισης, είτε του συνδυασμού αυξημένης παραγωγής και μειωμένης απέκκρισης του ουρικού οξέος, που πυροδοτεί, ενίοτε, την εμφάνιση φλεγμονώδους αρθρικής εξεργασίας.

Οι περισσότερες κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας εμφανίζονται μετά από 20 έως 40 χρόνια συνεχούς υπερουριχαιμίας, ενώ η συνήθης ηλικία έναρξης των φλεγμονωδών κρίσεων είναι μεταξύ 40 και 60 ετών για τους άνδρες και συνήθως μετά την εμμηνόπαυση στις γυναίκες. Στατιστικά, η αναλογία επίπτωσης της νόσου μεταξύ ανδρών/γυναικών είναι 9/1.

Στο 30% των περιπτώσεων οξείας ουρικής αρθρίτιδας η συγκέντρωση ουρικού οξέος στον ορό είναι φυσιολογική και, εάν είναι υψηλή δεν θα πρέπει να επιχειρείται η μείωση της μέχρι να υποχωρήσει η κρίση, δηλ. τα συμπτώματα και τα σημεία της φλεγμονής.

Κλινική εικόνα: Η προσβεβλημένη άρθρωση είναι εξέρυθρη, θερμή, οίδηματώδης και εξαιρετικά επώδυνη. Συχνά συνυπάρχει δεκατική ή ήπια πυρετική κίνηση η οποία στο 30% των περιπτώσεων μπορεί να φτάσει έως τους 38 °C. Εάν δεν εφαρμοστεί άμεσα θεραπεία, τότε η ένταση της αρθρικής προσβολής συνήθως κορυφώνεται μέσα σε 12-24 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και υποχωρεί σταδιακά μετά από 7-10 ημέρες.

Στο 80-90% των περιπτώσεων οι πρώτες κρίσεις είναι μονοαρθρικές και τουλάχιστον οι μισές από αυτές αφορούν στην 1^η μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση, εκδήλωση γνωστή ως «**ποδάγρα**» (gout). Άλλες αρθρώσεις που προσβάλλονται συνήθως, κατά σειρά συχνότητας, είναι: η ποδοκνημική, οι αρθρώσεις του ταρσού, της πτέρνας, του γόνατος, του καρπού, των δακτύλων και του αγκώνα. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με συχνές υποτροπές κρίσεων ουρικής αρθρίτιδας έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν πολυαρθρική αρθρίτιδα.

Θεραπευτική παρέμβαση

Η θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας κατά τη φάση της οξείας προσβολής, έχει ως στόχους τόσο την άμεση ανακούφιση από τον πόνο και τη φλεγμονή, όσο και την πρόληψη των μελλοντικών προσβολών και επιπλοκών, όπως το σχηματισμό τόφων και τη νεφρολιθίαση.

1. **ΜΣΑΦ:** Χορηγούμε **Ινδομεθακίνη**, ενδομυϊκά ή από το στόμα και τοπικά με αλοιφή.

- 1 amp. inj. sol. *Indocid* 3 mg (im), με επανάληψη της ένεσης σε 6 ώρες ή
- 1 tab. *Fortathrin* 75 mg (per os) 1x1 x 5d, & gel. *Reumadolor* 1% 1x2, τοπικά.

Εναλλακτικά της Ινδομεθακίνης, μπορεί να χορηγηθεί **Παρεκοξίμνη:**

- 1 amp. *Dynastat* 40 mg (im) ή (iv) διαλυμένη σε 100 ml N/S, εντός 15 λεπτών.

Εναλλακτικά, χορηγούμε **Δεξκετοπροφαίνη** ή **Ιβουπροφαίνη** ή **Ναπροξένη:**

- 1 amp. *Viaxal* 50 mg (im) ή (iv) διαλυμένη σε 100 ml N/S, εντός 15 λεπτών.
- tab. *Brufen* 600 mg (per os), 1x3 x 3d & 1x2 x 5d ή tab. *Brufen plus* 1x2 x 5d.
- tab. *Naprosyn* 250 mg (po), 1x3 x 3d & 1x2 x 5d, & gel. *Naprosyn* 10% 1x3 x 5d.

Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί **Μελοξικάμη** ή **Λορνοξικάμη** ή **Τενοξικάμη:**

- 1 amp. *Loxitan* 15 mg (im) ή tab. *Loxitan* 7,5 mg (po), 1x2 x 2d & 1x1 x 5d.
- 1 amp. *Xefo* 4 mg (im) ή tab. *Xefo Rapid* 8 mg (po), 1x2 x 3d & 1x1 x 5d.
- 1 amp. *Neo-Endusix* 20 mg (im) ή tab. *Admiral* 20 mg (po), 1x2 x 2d & 1x1 x 5d.

2. **Κολχικίνη:** Η δόση της δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4-6 mg, το 24ωρο της οξείας κρίσης. Γενικά, η κολχικίνη χορηγείται σε ασθενείς με καλή νεφρική λειτουργία, σε δοσολογία 1 mg δύο φορές την ημέρα, έως ότου ο πόνος και η φλεγμονή υποχωρήσουν ή μέχρι ο ασθενής να εμφανίσει γαστρεντερικές διαταραχές. Χορηγείται λοιπόν, ως ακολούθως:
 - ♦ 1 tab. Colchicine 1 mg, 1x3 ή 1x4, το πρώτο 24ωρο της οξείας κρίσης.
 - ♦ 1 tab. Colchicine 1 mg, 1x2 για άλλες 4-6 ημέρες, (θεωρητικά, max: 1,8 mg/24h).
3. Σκόπιμη κρίνεται η χορήγηση γαστροπροστασίας στον ασθενή, καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας [H_2 αναστολείς (*Lomadryl, Tagamet, Peptan*) ή PPIs (*Losec, Nexium, Pariet*)], για να τον προφυλάξουμε από τις πεπτικές παρενέργειες των ΜΣΑΦ και της Κολχικίνης.
4. **Γλυκοκορτικοστεροειδή:** Θεωρούνται ιδιαίτερος αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της οξείας ουρικής αρθρίτιδας (ιδίως στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να χορηγηθούν τα ΜΣΑΦ και η Κολχικίνη). Όταν η νόσος είναι πολυαρθρική ή προσβάλλει μεγάλες αρθρώσεις, όπως του γόνατος, η χορήγηση κορτικοστεροειδών θα πρέπει να γίνεται σε σχετικά μεγάλες δόσεις (π.χ. **Πρεδνιζολόνη (Prezolon)**, 40 mg/ημέρα, για 1-3 ημέρες, διαιρεμένα σε δύο δόσεις των 20 mg) και με βαθμιαία μείωση της δόσης κατά 10-15 mg, ανά 3 ημέρες, μέχρι τη διακοπή της χορήγησης σε συνολικό διάστημα δύο εβδομάδων.
5. **ACTH:** Η ενδομυϊκή χορήγηση της ACTH – κατά κανόνα – συνοδεύεται από θεαματικά αποτελέσματα. Σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών ο πόνος υποχωρεί λίγες ώρες μετά την πρώτη έγχυση του φαρμάκου, χωρίς να χρειαστεί επανάληψη. Στην καθ' ημέρα πράξη χρησιμοποιείται το ημισυνθετικό ανάλογο της ανθρώπινης ACTH (**Τετρακοσακτίδη**):
 - ♦ 1 amp. *Cortrosyn/Synacthen* 0,25 mg/ml (μέγιστη δόση: 2-3 ενέσεις).

Αγωγή κατ' οίκον:

1. **Αλλοπουρινόλη:** tab. *Soluric/Zylapour* 100 mg/24ωρο (για ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία και κάθαρση κρεατινίνης - *GFR* < 30 ml/min) έως και 600 mg/ημέρα (μέγιστη συνιστώμενη δόση), ενώ η συνήθης αρχική δόση είναι 300 mg/24ωρο (po).

Η αλλοπουρινόλη προκαλεί ταχεία ελάττωση των επιπέδων του ουρικού οξέος, καθώς και αποσταθεροποίηση των μικροτόφων στον αρθρικό υμένα, που έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνησή τους προς το αρθρικό υγρό και την πρόκληση έτσι επεισοδίου ουρικής αρθρίτιδας. Γι' αυτό, **δεν πρέπει να γίνεται έναρξη αγωγής με αλλοπουρινόλη σε κρίση ουρικής αρθρίτιδας**. Εάν όμως ο ασθενής λαμβάνει ήδη αγωγή με αλλοπουρινόλη, τότε δεν διακόπτεται η χορήγησή της, αλλά συγχωρηγείται με την κολχικίνη ή τα ΜΣΑΦ.

2. Εναλλακτικά, αντί της Αλλοπουρινόλης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η **Φεμπουξοστάτη (Adenuric)**. Η συνιστώμενη, από του στόματος, δόση του Adenuric είναι 80 mg άπαξ ημερησίως, ανεξάρτητα από τροφές. Εάν το ουρικό οξύ του ορού παραμένει > 6 mg/dl έπειτα από 2-4 εβδομάδες αγωγής, μπορεί να εξεταστεί η χορήγηση Adenuric 120 mg άπαξ ημερησίως. Η Φεμπουξοστάτη μειώνει τα επίπεδα του ουρικού οξέος περισσότερο από ό,τι η αλλοπουρινόλη σε ηλικιωμένους με ουρική αρθρίτιδα και σε άτομα με ήπια έως μέτριο βαθμού ΧΝΝ. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή ασθενείς ηλικίας > 65 ετών με ΧΝΝ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν υψηλές ή μέγιστες δόσεις Αλλοπουρινόλης.
3. **Διατροφικές οδηγίες:** *Αποφεύγονται τα οινοπνευματώδη, τα θαλασσινά (οστρακοειδή), οι ρέγγες, οι αντσούγες, οι σαρδέλες, ο τόνος, το κυνήγι, ο σπλήνας, τα νεφρά, το συκώτι, οι τηγανιτές πατάτες και γενικώς τα τηγανητά, τα αλλαντικά, τα μανιτάρια, τα σπαράγγια, το σπανάκι, το σέλινο, και οι μεγάλες ποσότητες καφέ ή κακάο (βλ. σελ. 409).* Προτείνεται ο έλεγχος των επιπέδων του ουρικού οξέος στον ορό, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η διατροφική αγωγή πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ελαττώνει το ουρικό οξύ του ορού σε επίπεδα: $UA < 6 \text{ mg/dl}$, ώστε να μην εμφανίζονται συχνές κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας και σε επίπεδα ουρικού οξέος < 5 mg/dl για να αποφύγουμε τον σχηματισμό ουρικών τόφων.
4. Συστήνουμε επίσης στους ασθενείς να πίνουν τουλάχιστον δύο λίτρα υγρών ημερησίως.